

Les vascularites systémiques

I. Généralités :

- Les vascularites systémiques sont un groupe de maladies hétérogènes ayant en commun une inflammation de la paroi vasculaire
- Ce sont des maladies graves ; elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel de l'organe atteint
- Leur pronostic dépend d'un diagnostic et d'un traitement précoce
- Le tableau clinique est hétérogène non spécifique, souvent est retrouvé dans les formes systémique un amaigrissement et/ou fièvre

II. Définition :

- Une vascularite est l'inflammation de la paroi vasculaire qui peut toucher les petits vaisseaux (capillaires, veinules, artérioles), moyens (artères et veines) ou grand calibre
- Cette inflammation est d'origine immunologique

III. Physiopathologie :

- L'inflammation de la paroi vasculaire est de mécanisme immunologique (dépôt de complexes immuns, dépôt du complément, recrutement de cellules inflammatoires par sécrétion de substances pro inflammatoires vers la paroi vasculaire
- Cette inflammation aboutit soit à :
 - Une occlusion de la lumière vasculaire par de l'inflammation avec épaissement de l'intima ou par un thrombus entraînant une ischémie et nécrose tissulaire
 - Destruction de la paroi vasculaire à l'origine d'anévrisme

IV. Signes cliniques :

- Amaigrissement souvent présent dans les atteintes diffuses, surtout si aucune cause n'est retrouvée
- Fièvre type de fébricule ou réelle hyperthermie pseudo infectieuse qui n'a pas fait preuve d'une origine infectieuse
- Manifestations cutanées : purpura vasculaire, livedo réticulais, urticaire, nécroses cutanées et digitales, nodules cutanés, érythème noueux
- Manifestations musculaires : myalgie, déficit musculaire, ...
- Manifestations digestives : douleur abdominale, hémorragie digestive, infarctus mésentérique
- Manifestations articulaires : arthralgies, mono-arthrite ou polyarthrite
- Manifestations respiratoires : asthme, dyspnée voire détresse respiratoire
- Manifestations rénales et vasculaires : insuffisance rénale rapidement progressive, HTA
- Manifestations neurologiques : mono ou multinévrite

V. Classification :

- Les vascularites ont pu être classé en fonction du type et de la taille des vaisseaux atteint
- La classification avec nomenclature de Chapel Hill, révisée en 2012 est une référence (voir tableau, différentes vascularites)

Vascularites des petits vaisseaux	Vascularites à ANCA • Polyangéite microscopique • Granulomatose avec polyangéite • Granulomatose éosinophilique avec polyangéite Vascularite à complexe immuns • Vascularite à anti-Membrane Basale Glomérulaire • Vascularite cryoglobulinémique • Vascularite à IgA • Vascularite urticarienne hypocomplémentémique à anticorps anti C1q
Vascularites des vaisseaux de moyen calibre	• Polyartérite noueuse • Maladie de Kawasaki
Vascularite des gros vaisseaux	• Maladie de Takayasu • Artérite à cellules géantes (Maladie de Horton)
Vascularite de vaisseaux de taille variable	• Maladie de Behçet • Syndrome de Cogan

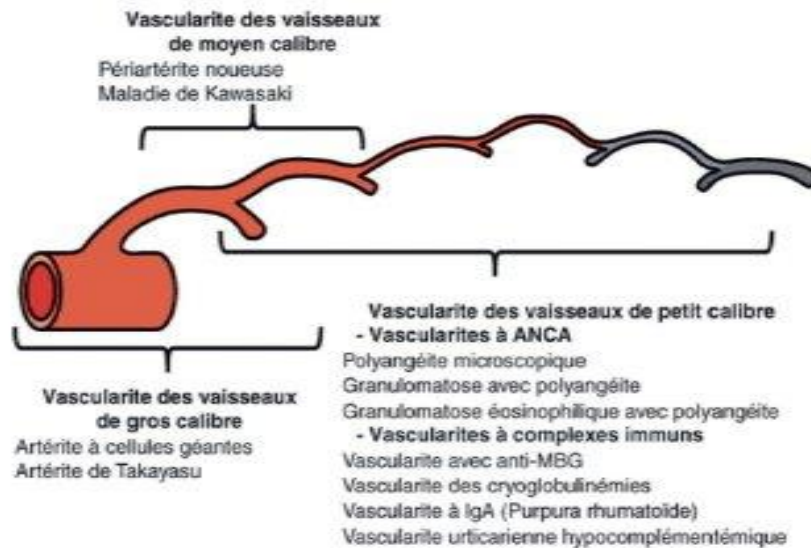


Figure 6. Causes de vascularites selon la topographie des vaisseaux

VI. Principales vascularites :

A. Les vascularites à petits vaisseaux :

- Les vascularites à ANCA : sont aussi connus par la présence d'anticorps dits de type ANCA (anticorps anti cytoplasme des polynucléaires)
 1. **Granulomatose avec polyangéite (GPA)** : anciennement appelé maladie de Wegener, est caractérisée par :
 - Atteinte ORL volontiers inaugural (sinusite, rhinite croûteuse trainante)
 - Atteinte rénale glomérulaire (hématurie, protéinurie, insuffisance rénale rapidement progressive)
 - Atteinte pulmonaire (nodules, infiltrat pulmonaire, capillarite pulmonaire avec hémoptysie par hémorragie alvéolaire voir atteinte pneumo rénale)
 - Rarement une atteinte oculaire inflammatoire (sclérite, épisclérite, vascularite rétinienne, pseudotumeur orbitaire).
 - Les ANCA sont souvent retrouvés de spécificité antiprotéinase 3 (anti PR3)
 2. **La granulomatose éosinophilique avec polyangéite** : anciennement appelée syndrome de Churg et Strauss est caractérisée par :
 - L'association d'un asthme sévère et d'une hyper éosinophile sup à 1500 éléments/mm³ et d'autres manifestations : sinusite, polypes nasaux, infiltrats pulmonaires, neuropathie périphérique, purpura, atteinte cardiaque (péricardite, myocardite)
 - L'atteinte rénale est rare
 - Présence d'ANCA de spécificité antimyéloperoxydase (MPO)
 3. **Polyangéite microscopique** : est caractérisée par :
 - Un purpura
 - Une atteinte rénale de type glomérulaire (hématurie, protéinurie, insuffisance rénale rapidement progressive par glomérulonéphrite extra capillaire)
 - Atteinte pulmonaire (capillarite pulmonaire avec hémoptysie par hémorragie alvéolaire) voire atteinte pneumo rénale
 - Présence d'ANCA de type MPO parfois de type PR3
- Purpura rhumatoïde ou vascularite à IgA (purpura de Schonlein-Hénoc) : Atteint préférentiellement les enfants un peu plus les garçons entre 5 et 15 ans parfois touche l'adulte aussi. Est caractérisé par :
 - Un purpura déclive
 - Des douleur articulaire
 - Douleur abdominale voir hémorragie digestive
 - Atteinte rénale
 - Évolue par poussées souvent vers la guérison spontanée
 - Diagnostic : biopsie cutanée ou rénale : vascularite avec dépôts d'IgA

B. Les vascularites de vaisseaux de moyen calibre :

1. Périartérite noueuse ou PAN : est caractérisée par :

- Manifestation cutanée type purpura vasculaire, livedo, nodules cutanés
- Une HTA rénovasculaire
- Manifestations digestives (douleur abdominale, diarrhée, hémorragie digestive, infarctus mésentérique, perforation.
- Manifestations neurologiques type multinévrite
- Présence classique de micro anévrysmes rénaux, hépatiques ou digestifs à l'artériographie

2. La maladie de Kawasaki :

- Est une vascularite aiguë des vaisseaux de moyen calibre et à moindres degrés de petit calibre avec un tropisme pour les artères coronaires.
 - Une maladie infantile : touche l'enfant entre 6 mois et 5 ans avec un max vers 2 ans
 - Clinique :
 - Début aigu par une fièvre supérieur à 38,5° de 1 à 2 semaines
 - Une conjonctivite avec photophobie
 - Une atteinte de la muqueuse buccale réalisant un érythème ou pharyngite, une langue framboise et chéilite douloureuse (lèvres rouges et fissurées)
 - Des adénopathies cervicales
 - Un exanthème type scarlatiniforme ou morbiliforme au niveau des membres, tronc et du siège suivi d'une desquamation périnéale caractéristique
 - Érythème des paumes des mains et plantes des pieds suivi d'une desquamation des pulpes
 - Une atteinte cardiaque est à redouter donc à surveiller type myocardite, vascularite des coronaires qui peut évoluer vers des anévrysmes
 - Traitement : immunoglobulines et aspirine
- ✓ Le traitement des vascularites de petit et moyen calibre dépend du type, de sa gravité : consiste à la phase aiguë d'un traitement pour induire une rémission instauré précocement voir en urgence suivi d'un traitement d'entretien pour maintenir la rémission et éviter les rechutes
- ✓ Dans les formes sévères de vascularites, principalement maladie de Wegener : le cyclophosphamide ou le rituximab sont utilisés en induction en association avec les corticoïdes relais par rituximab en perfusion semestrielle
- ✓ Dans les formes sans critères de sévérité de PAN ou GEPA : la corticothérapie est utilisée seule en 1^{ère} intention

C. Les vascularites des gros troncs : (aorte et ses branches) : regroupent :

1. L'artérite à cellules géantes (ACG) ou maladie de Horton :

- C'est une vascularite qui touche avec prédilection l'aorte et ses branches surtout à destination céphalique
- Touche le sujet âgé avec un âge moyen de 70 ans
- La forme complète et typique de la maladie se présente par :
 - Une altération de l'état général, fièvre, amaigrissement, fatigue
 - Céphalée au niveau des tempes uni ou bilatérale rebelle avec une hypersensibilité du cuir chevelu
 - Artère temporale dure peu battante
 - Claudication de la mâchoire
 - Des douleurs articulaires surtout des épaules avec faiblesse musculaire des ceintures réalisant une PPR
 - Troubles visuels (diplopie, neuropathie optique ischémique antérieure qui peut évoluer vers la cécité)
- Diagnostic : critères de classification ACR (âge supérieur à 50 ans, céphalée de début récent, artère temporale indurée, VS supérieure à 50mm 1^{ère} heure, biopsie de l'artère temporale : une panartérite granulomateuse avec destruction de la limitante élastique interne

-

2. L'artérite de Takayashu (AT) :

- Survient chez la femme jeune, maladie des femmes sans pouls
- Touche l'aorte et ses branches, évolue vers la fibrose et sténose artérielle
- Évolue en deux phases : inflammatoire avec symptômes non spécifiques tels : fièvre, syndrome général, puis phase non inflammatoire révélée par des signes d'ischémie dans les territoires atteints (HTA rénovasculaire, claudication d'un membre)
- Traitement : corticothérapie ++, immunosuppresseur

VII. Complications :

- Fonction de la sévérité
- Insuffisance rénale terminale, hémorragie alvéolaire grave, risque de décès
- Maladie de Horton → cécité
- Maladie de Takayashu → HTA

VIII. Diagnostic différentiel : Vascularites secondaires :

- D'origine infectieuse (endocardite bactérienne, hépatite C et autres)
- D'origine toxique ou médicamenteuse
- Maladies systémiques auto-immunes (LED, syndrome de Gougerot-Sjögren)
- À une néoplasie (hémopathie type lymphome, cancer solide)

IX. Traitement :

• But :

- Induire une rémission
- Prévenir la récurrence

• Armes :

- Corticothérapie
- Immunosuppresseurs
- Biothérapie